

기 관 경 고

1. 제 목 : 영상진단 판독 및 청구 관리 부적정
2. 관계기관 : □□·○○·△△·◇◇ 병원
3. 내 용 : □병원에서는 X-Ray 등 단순영상촬영 및 MRI·CT 등 특수영상 촬영 검사를 실시·판독하여 환자들 질환에 대한 정확한 진단을 하고 있습니다.

보건복지부 고시 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제3장 제1절(방사선단순영상진단료) 및 제2절(방사선특수영상진단료)에는 상근하는 영상의학과 전문의가 판독을 하고 판독소견서를 작성한 경우에는 해당 영상진단료에 소정점수의 10%를 가산하여 건강보험심사평가원으로 청구하도록 되어 있습니다.

또한 위 고시에는 전문의가 판독 소견서를 작성하지 않은 경우에는 촬영료 등(소정점수의 70%)만 산정하도록 되어 있으며, 판독소견서 작성 시점은 환자치료(치료계획) 전까지로 하되, 부득이한 사정이 있는 경우에는 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 청구하기 전까지 작성하여야 한다고 되어 있습니다.

그러므로 각 □병원에서는 영상촬영 후 요양급여 및 국비보상금 청구(정산) 등은 상근하는 영상의학과 전문의가 판독한 경우에만 10%의 가산수가를 청구하여야 하고, 전문의가 요양급여비용 청구전까지 판독소견서를 작성한 경우에만 판독료(소정점수의 30%)를 포함하여 수가의 100%를 청구함으로써 부당 청구 등 논란의 소지가 없도록 관리하여야 합니다.

그러나 □□·○○·△△·◇◇ 보훈병원에서는 영상의학과 전문의들의 정원 부족 등을 사유로 촬영한 영상의 판독을 적기에 하지 못하였고, 진료과 전문의들은

업무과중 또는 청구기준 미숙지 등의 사유로 적기에 촬영한 영상을 미판독하거나, 판독을 하였으나 판독소견서를 작성하지 못한 사례가 발생하였습니다. 또한 □부(○부)에서는 영상촬영 시 이루어지는 수납과 판독 및 청구시점 차이, 심사 대상 수량의 과다로 인한 문제 등으로 인해 검사 건별로 확인이 곤란하다는 사유 등으로 판독가산(10%) 해당 여부, 전문의 판독여부(수가의 30%)를 확인하지 않고 일괄 청구(정산)하여왔습니다.

그 결과 상근하는 영상의학과 전문의 판독에 의한 가산료(10%) 청구분 중 국비부담금 816백만원(□□ 361, ○○ 282, △△ 100, ◇◇ 73백만 원) 및 건강보험 부담금 등 248백만 원(○○ 130, △△ 74, ◇◇ 44백만 원)상당이 잘못 정산되었으며, 전문의 판독(수가의 30%) 여부에 따른 청구분 중에도 국비부담금 434백만원(□□ 337, ○○ 2, △△ 2, ◇◇ 93백만 원) 및 건강보험부담금 등 198백만 원(□□ 163, ○○ 1, △△ 1, ◇◇ 33백만 원)상당이 잘못 정산된 것으로 추정되었습니다.

4. 조치할 사항

○ 이사장은

- 영상진단료 청구 시 일부 의료영상에 대해 상근하는 영상의학과 전문의가 판독하지 않았는데도 판독가산료(영상진단료 10%가산)를 잘못 청구하거나, 진료과 전문의들이 판독소견을 작성하지 않았는데도 (영상진단료 30%해당) 이를 구분 청구하지 않아 결과적으로 부당청구의 소지를 제공하는 등 영상진단 판독 및 청구를 부적절하게 관리한 □□·○○·△△·◇◇ 보훈병원에 동일사례 재발방지를 위하여 「기관경고」 조치하시기 바랍니다.(기관경고)